

ENDOFTALMITE — EMERGÊNCIA — ATB INTRAVÍTREO

CLASSIFICAÇÃO DA ENDOFTALMITE

Tipo	Contexto	Agentes
Pós-operatória aguda	Dias após cirurgia (catarata, mais comum) <6 semanas	S. epidermidis (mais comum), S. aureus, estreptococos
Pós-operatória crônica	>6 semanas após cirurgia, indolente	P. acnes, fungos, S. epidermidis
Pós-traumática	Trauma penetrante com corpo estranho	Bacillus cereus (grave), S. epidermidis, fungos
Endógena (hematogênica)	Disseminação de foco à distância (sepse, endocardite, abscesso)	Candida (fungo), bactérias Gram-negativas, S. aureus
Associada a bolha filtrante	Pós-trabeculectomia (glaucoma)	Estreptococos, H. influenzae

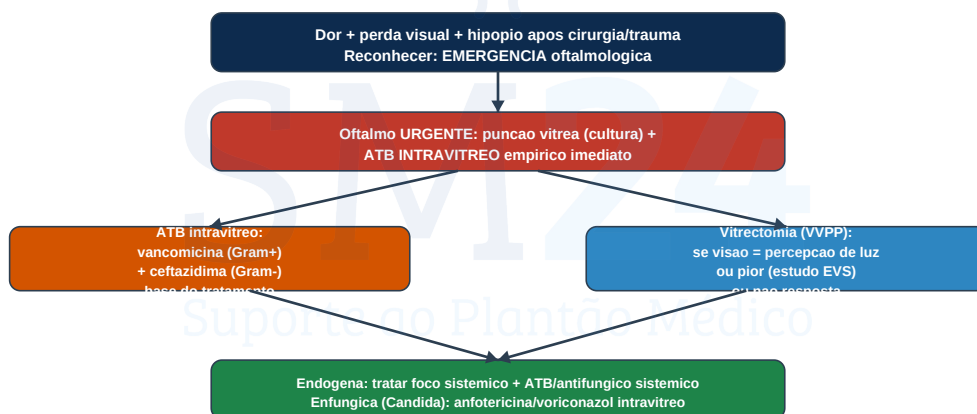
QUADRO CLÍNICO — EMERGÊNCIA OFTALMOLÓGICA

DOR + PERDA VISUAL + HIPÓPIO APÓS CIRURGIA/TRAUMA

- Dor ocular intensa (de início ou piora) após cirurgia ou trauma ocular
- Perda visual rápida e progressiva
- Hipópio: nível de pus na câmara anterior (achado característico)
- Olho vermelho, edema palpebral, quemose, secreção
- Vitreíte: turvação do vítreo à fundoscopia (reflexo vermelho diminuído/ausente)
- Tempo é crítico — ATB intravítreo IMEDIATO; atraso = perda irreversível da visão

MANEJO DA ENDOFTALMITE

ENDOFTALMITE — PUNÇÃO + ATB INTRAVÍTREO JÁ



TRATAMENTO — ANTIBIÓTICOS INTRAVÍTREOS

Droga	Espectro	Observação
Vancomicina intravítrea	Gram-positivos (S. epidermidis, S. aureus)	Base do tratamento empírico
Ceftazidima intravítrea	Gram-negativos (Pseudomonas)	Associada à vancomicina
Amicacina (alternativa)	Gram-negativos	Se alergia à ceftazidima (risco de toxicidade retiniana)
Anfotericina B / voriconazol	Fungos (Candida, Aspergillus)	Endoftalmite fúngica (endógena, pós-traumática)
Corticoide intravítreo	Reduz inflamação	Uso controverso, após cobertura ATB

EVS (ENDOPHTHALMITIS VITRECTOMY STUDY)

Conduta Baseada na Visão

- Visão = percepção de luz (PL) ou pior: VITRECTOMIA imediata + ATB intravítreo
- Visão melhor que PL (conta dedos+): punção vítrea + ATB intravítreo (sem vitrectomia inicial)
- ATB sistêmico não mostrou benefício adicional no EVS para endoftalmite pós-catarata
- ATB intravítreo é o pilar (atinge concentração eficaz no local)
- Reavaliação em 48h — repetir ATB intravítreo ou vitrectomia se piora

Prevenção e Endógena

- Profilaxia em cirurgia de catarata: cefuroxima intracameral reduz endoftalmite
- Antissepsia com povidona-iodo no campo cirúrgico
- Endoftalmite endógena: investigar foco (hemocultura, eco, exame físico)
- Candidemia: fundoscopia para rastrear envolvimento ocular
- Tratar foco sistêmico + ATB/antifúngico sistêmico + intravítreo
- Bacillus cereus pós-trauma: evolução fulminante — prognóstico reservado

ABORDAGEM NO PS

NÃO PERDER TEMPO

- ☐ Endoftalmite é emergência oftalmológica — encaminhamento e tratamento IMEDIATOS
- ☐ Suspeitar em dor + perda visual + hipópio após cirurgia ocular (sobretudo catarata) ou trauma
- ☐ Tratamento: punção vítrea para cultura + ATB intravítreo empírico (vancomicina + ceftazidima)
- ☐ Vitrectomia se visão = percepção de luz ou pior (EVS)
- ☐ Endoftalmite endógena: buscar e tratar o foco infeccioso sistêmico
- ☐ Suspeitar de fungo (Candida) em endógena, pós-trauma e usuário de drogas IV

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente operado de catarata há 3 dias retorna com dor ocular intensa, perda visual e hipópio. Qual é o diagnóstico e a conduta?

- A) Conjuntivite pós-operatória — colírio antibiótico
- B) Endoftalmite pós-operatória aguda — emergência: punção vítrea + antibiótico intravítreo imediato
- C) Glaucoma agudo — pilocarpina
- D) Uveíte anterior — corticoide tópico
- E) Edema de córnea — solução hipertônica

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o agente mais comum da endoftalmite pós-operatória aguda (pós-catarata)?

- A) Pseudomonas aeruginosa
- B) Staphylococcus epidermidis (coagulase-negativo)
- C) Candida albicans
- D) Bacillus cereus
- E) Streptococcus pneumoniae

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Segundo o EVS (Endophthalmitis Vitrectomy Study), em qual situação a vitrectomia imediata está indicada?

- A) Em todos os casos de endoftalmite
- B) Quando a acuidade visual é de percepção de luz (PL) ou pior
- C) Apenas em endoftalmite fúngica
- D) Quando há hipópio pequeno
- E) Somente após 7 dias de antibiótico intravítreo

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o esquema empírico de antibiótico INTRAVÍTREO para endoftalmite bacteriana?

- A) Penicilina + gentamicina
- B) Vancomicina + ceftazidima
- C) Azitromicina isolada
- D) Ciprofloxacino tópico apenas
- E) Metronidazol + ampicilina

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com candidemia deve ser submetido a fundoscopia porque:

- A) A Candida sempre causa catarata
- B) Pode haver endoftalmite endógena por disseminação hematogênica da Candida, exigindo tratamento específico
- C) A fundoscopia confirma a candidemia
- D) É necessário para liberar antibiótico sistêmico
- E) A Candida causa descolamento de retina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Endoftalmite pós-operatória aguda: dor + perda visual + hipópio dias após cirurgia (catarata é a mais associada). Emergência oftalmológica — punção vítrea (cultura) + ATB intravítreo empírico imediato (vancomicina + ceftazidima). Vitrectomia se visão = PL ou pior. Atraso = cegueira.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Staphylococcus epidermidis (coagulase-negativo), da flora da própria pálpebra/conjuntiva, é o agente mais comum da endoftalmite pós-operatória aguda. Outros: S. aureus, estreptococos. A profilaxia com cefuroxima intracameral reduz a incidência.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

EVS: vitrectomia imediata indicada quando a acuidade visual é percepção de luz (PL) ou pior — melhora os desfechos visuais nesses casos graves. Visão melhor que PL (conta dedos+): punção vítrea + ATB intravítreo sem vitrectomia inicial. ATB sistêmico sem benefício na pós-catarata.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O esquema empírico intravítreo combina vancomicina (cobre Gram-positivos, incluindo S. epidermidis e S. aureus) + ceftazidima (cobre Gram-negativos, incluindo Pseudomonas). Amicacina é alternativa à ceftazidima, mas tem risco de toxicidade retiniana.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A candidemia pode disseminar para o olho (endoftalmite endógena por Candida), com lesões coriorretinianas e vitreíte. A fundoscopia é recomendada para rastrear envolvimento ocular, que exige tratamento específico (antifúngico sistêmico +/- intravítreo) e prolongamento do tratamento.

SM24
Suporte ao Plantão Médico